

TEMA 3.22 • OBSTETRICIA

Síndrome Hipertensivo del Embarazo — Diagnóstico y Clasificación

PERFIL EUNACOM 2.01.2.017
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndrome Hipertensivo del Embarazo — Diagnóstico y Clasificación

Diagnóstico de HTA en el Embarazo

TABLA 3.22.1: CRITERIO VS VALOR	
CRITERIO	VALOR
Una toma	PA ≥ 160/110 mmHg → confirma SHE (crisis hipertensiva)
Varias tomas en 6h	PA ≥ 140/90 persistente → confirma SHE

Clasificación (2 criterios: EG y proteinuria)

TABLA 3.22.2: EG VS PROTEINURIA		
EG	PROTEINURIA	DIAGNÓSTICO
< 20 semanas	Negativa	HTA crónica
< 20 semanas	Positiva	HTA crónica + nefropatía
≥ 20 semanas	Negativa	HTA gestacional (transitoria)
≥ 20 semanas	Positiva	Preeclampsia

Proteinuria positiva: > 300 mg/día o índice proteína/creatinina > 0,3

Excepciones a la regla de las 20 semanas

- Embarazo gemelar / molar → pueden tener preeclampsia < 20 semanas
- Criterios de severidad presentes → = preeclampsia severa aunque no haya proteinuria

Criterios de Severidad de la Preeclampsia

Con cualquiera de los siguientes → preeclampsia SEVERA:

TABLA 3.22.3: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS
CRITERIO
Eclampsia (convulsiones o coma)
Exaltación neurológica (tinnitus, fotopsias, hiperreflexia, cefalea, confusión)
Síndrome de HELLP o cualquiera de sus componentes (plaquetas < 100.000, transaminasas ↑, anemia hemolítica)
Edema pulmonar agudo
CID
Insuficiencia renal aguda
PA ≥ 160/110 mmHg
Proteinuria ≥ 5 g/día (rango nefrótico o mayor)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Basta UN criterio para diagnóstico de preeclampsia severa. Cero criterios → preeclampsia no severa → control semanal.

Casos Prácticos

TABLA 3.22.4: CASO VS EG			
CASO	EG	PROTEINURIA	DIAGNÓSTICO
34 años, 13 sem	< 20	Negativa	HTA crónica
44 años, 17 sem	< 20	1 g/día	HTA crónica + nefropatía
22 años, 32 sem	≥ 20	1 g/día	Preeclampsia
44 años, 33 sem	≥ 20	Negativa	HTA gestacional
28 años, gemelar 18 sem	< 20 (exc)	1 g/día	Preeclampsia (excepción: gemelar)

| 12 sem: PA alta + 0,5 g/dL → a 32 sem sube a 2 g | < 20 → progresa | Crece | HTA crónica + nefropatía → PE sobreagregada |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Síndrome Hipertensivo del Embarazo — Diagnóstico y Clasificación: Exaltación neurológica (tinnitus, fotopsias, hiperreflexia, cefalea, confusión) ... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome Hipertensivo del Embarazo — Diagnóstico y Clasificación. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico de HTA en el Embarazo
- Clasificación (2 criterios: EG y proteinuria)
- Excepciones a la regla de las 20 semanas
- Criterios de Severidad de la Preeclampsia
- Casos Prácticos
- | PA ≥ 160/110 mmHg → confirma SHE (crisis hipertensiva) | |
- HTA crónica + nefropatía

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO — DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN)**PREGUNTA 1**

En relación a Síndrome Hipertensivo del Embarazo — Diagnóstico y Clasificación: Exaltación neurológica (tinnitus, fotopsias, hiperreflexia, cefalea, confusión) ... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Síndrome Hipertensivo del Embarazo — Diagnóstico y Clasificación se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Síndrome Hipertensivo del Embarazo — Diagnóstico y Clasificación debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Síndrome Hipertensivo del Embarazo — Diagnóstico y Clasificación requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Síndrome Hipertensivo del Embarazo — Diagnóstico y Clasificación es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Síndrome Hipertensivo del Embarazo — Diagnóstico y Clasificación no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Síndrome Hipertensivo del Embarazo — Diagnóstico y Clasificación?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Síndrome Hipertensivo del Embarazo — Diagnóstico y Clasificación. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: SÍNDROME HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO — DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN

:::tip Basta UN criterio para diagnóstico de preeclampsia severa. Cero criterios → preeclampsia no severa → control semanal. :::